UE B.1 • MÉMORISER • S1

Douleur • bases et mécanismes

Révision active • définitions, raisonnement, rôle IDE

DÉFINITION IASP (2020)

Expérience sensorielle ET émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à celle associée à, une lésion réelle ou potentielle.

NOCICEPTION ≠ DOULEUR

Nocicepteurs : détectent un stimulus nocif. Douleur : expérience consciente et personnelle. La parole du patient est à respecter.

4 DIMENSIONS

Sensorielle (où, combien, comment) • affective (pénibilité, peur) • cognitive (sens, mémoire, croyances) • comportementale (protection, mimiques).

BIOPSYCHOSOCIAL

Biologie + émotions/pensées + contexte social interagissent. Douleur réelle même sans lésion visible proportionnelle.

UE B.1 • MÉMORISER • S1

Douleur • bases et mécanismes

Entraînement et auto-évaluation • corrigé au verso

VOIES

Stimulus → transduction → transmission (nerfs/moelle/cerveau) → modulation (frein/amplification) → perception intégrée.

MÉCANISMES

Nociceptive : tissus; neuropathique : système somatosensoriel lésé/malade; nociplastique : nociception altérée sans lésion explicative suffisante. Coexistence possible.

TEMPS

Aiguë : souvent signal d’alarme. Chronique : persiste/récidive > 3 mois, retentissement propre. Chronique ne veut pas dire simulée.

RÔLE IDE

Écouter • outil adapté • décrire/évaluer • agir selon cadre prescrit/protocole • réévaluer et tracer. Jamais minimiser ni conclure seul.